

34 - FMPM MOOCs - Les péritonites aiguës - Pr. Louzi

Bonjour chers étudiants, le cours d'aujourd'hui s'intitule les péritonites aiguës, c'est un cours de pathologie digestive chirurgicale de troisième année de médecine. Les péritonites aiguës, la première diapo, c'est ce qu'on pense lorsqu'on pense un malade qui a une péritonite aiguë, c'est l'existence depuis à l'intérieur de la cavité abîmée, ça c'est une vue scéliscopique, donc c'est ce qu'on pense à trouver depuis lorsqu'on va penser à une péritonite aiguë ou opérer un patient pour une péritonite aiguë. La péritonite aiguë, elle se définit par une inflammation aiguë de la serreuse péritoniale.

Vous allez voir qu'elle va être inflammée avec présence de liquide et surtout depuis, on va le voir, mais ça c'est un symptôme, c'est une conséquence de plusieurs pathologies, on va les voir tout au long du cours et sans plusieurs. Le diagnostic d'une péritonite, il est surtout clinique, mais parfois on a des difficultés, on va céder des éléments biologiques, sinon des examens radiologiques pour porter le diagnostic. C'est une extrême urgence chirurgicale parce que sinon on aura des complications qui peuvent être mortelles, donc le diagnostic se doit d'être précoce pour pouvoir prendre en charge ces patients-là qui ont une péritonite aiguë parce que lorsqu'on retarde le diagnostic, on peut avoir un pronostic qui est péjoratif.

Les objectifs du cours sont les présents, c'est connaître, expliquer la physiopathologie d'une péritonite aiguë, comment faire le diagnostic d'une péritonite aiguë, comment établir et faire le diagnostic étiologique d'une péritonite parce qu'on aura le traitement qui va changer et puis connaître les principes de la prise en charge thérapeutique des péritonites aiguës. Sur le plan physiopathologique, le péritoïde, vous commencez, on a deux péritoïdes, on a un péritoïde pariétal et viscéral, ce qui limite un espace virtuel où on peut avoir un petit peu de liquide. Il est contenu dans la cavité péritoniale.

La fonction du péritoïde, c'est quoi? C'est la sécrétion de plusieurs produits, un liquide qui va être riche en protéines, surtout en moyens de défense cellulaire, les glycytes, les histocytes, les macrophages autres choses. Il a un rôle mécanique, c'est la résorption, la résorption, la résorption de liquide. Donc on aura une sécrétion de liquide qui contient plusieurs choses et la résorption, on aura un équilibre entre la sécrétion et la résorption.

C'est surtout un moyen de défense immunitaire, cellulaire et éventuellement mécanique. Ça, c'est le rappel physiopathologique, physiologique du péritoïde. Dans la physiologie, on a parlé des étiologies des péritonites.

On peut avoir plusieurs types de péritonites. La péritonite peut être généralisée le plus souvent. Elle peut être localisée à un espace de l'abdomen.

Dans les péritonites généralisées, le plus souvent, elles sont secondaires. Secondaire à quoi? Secondaire à la perforation d'un organe creux abdominal, l'estomac, duodénum, l'intestin grêle, le colon, l'appendice. Donc, on aura la perforation de ces organes là.

Sinon, on peut avoir un foyer infecté comme la bésicubilia qui est infectée. Il va donner, il va donner une péretronite, un épanchement péruré long dans l'ombre. Une, une, une, une étiologie bien particulière, c'est les péretronites.

Ils sont particulières. On est obligé de les faire étudier. C'est un post-opérateur.

Lorsqu'on a quelqu'un qui a un problème abdominal, il peut par la suite faire une péretronite post-opératoire qui est difficile à diagnostiquer, à traiter. Ça, c'est les péretronites généralisées secondaires. Les péretrones généralisées peuvent être primitives.

On les trouve chez les patients qui sont immunodéprimés. C'est comme les sérotiques. On aura qui ont de l'acide qui vont s'infecter.

Ils vont donner un, une péretronite, mais il est primitif. Les gens qui ont un état immuno immunitaire déficient. Donc, ils peuvent faire des péretronites primitifs comme le diabétique déséquilibré et les états comme les cancéreuses sous chimiothérapie.

Les gens qui ont une, un syndrome immunodéficientaire acquis, le SIDA qui ne sont pas immunodéprimés, non traités. Ils peuvent faire ces péretronites primitives. Donc, à côté des généralisées, on aura les péretronites localisées.

Si vous avez du pus dans un, dans une partie de l'abdomen, vous aurez les collections dans le Douglas. Lorsque vous avez une infection génitale ou autre chose, on peut avoir une péretronite localisée dans le pelvis. Sinon, on peut avoir du pus en sophrénique, le plus souvent droit ou gauche.

On parle de péretronites localisées ou bien d'abcès sophrénique. Dans le cas particulier des péretronites par perforation d'organes creux, on peut avoir des péretronites chimiques. Au début, c'est que vous avez un liquide comme le liquide gastrique, liquide diodénale.

Il n'y a pas beaucoup de germes. Il n'y a pas de germes, sinon il y a une bactérie bien particulière. Et par contre, il y a un liquide qui est corrosif qui va qui va brûler, qui va faire une irritation du péritone, ce qu'on appelle les péretronites chimiques.

Et par la suite, il peut se mettre. Les péretronites bactériennes, c'est vous aurez comme les péretronites appendiculaires. Vous aurez le l'appendice qui est plein de pus.

On va avoir du pus avec des bactéries qui sont déversées dans la cavité abdominale. Les péretronites combinées au mix, c'est comme par exemple le colon, bien évident, vous aurez le liquide, il est corrosif, mais en plus de corrosif, de sa corrosion, on peut avoir des bactéries. C'est pourquoi on parle de péretronites mix.

Les conséquences générales pour comprendre la clinique et la rapidité d'installation des phénomènes, des phénomènes inflammatoires et hémodynamiques. On peut avoir, on peut, on va voir les répercussions de la de la péretronite sur sur l'organisme. Les conséquences

générales, on va avoir un problème respiratoire, une défaillance respiratoire.

C'est que l'ampliation d'orage qui va être diminuée par l'irritation du péricitone, ça fait énormément mal que le patient n'arrive pas à respirer. Il a de la difficulté, il a tellement mal. Et puis le diaphragme, il n'arrive pas à bouger parce que ça fait mal.

C'est pourquoi on va avoir une difficulté à respirer. Sinon, on peut avoir tellement le péricitone au niveau du diaphragme, il est très inflammé, il va être paralysé. On aura un patient qui va avoir une défaillance respiratoire.

On va le trouver dans les péritonites avancées. C'est des gens qu'on arrive, qui ont une difficulté à respirer, surtout une polypnée avec une dyspnée douloureuse. La défaillance circulatoire, vous aurez la sécrétion lorsqu'on a une inflammation, une irritation du péricitone.

On va avoir une sécrétion qui est exagérée, qui va dépasser la résorption de liquide. Donc, on aura un liquide intra-péricitone. Et ce liquide, c'est ce qu'on appelle le troisième secteur.

Le troisième secteur par définition, c'est le secteur qui ne participe pas aux échanges intercellulaires. Donc, le patient, il ne va pas perdre ses liquides, mais il sent. Ici, dans l'endommagement, c'est pourquoi on aura un patient qui va avoir des signes circulatoires, donc de manque de liquide dans le vaisseau.

Et puis, par l'infection et la déviation de pas mal de substances inflammatoires, on va avoir les vaisseaux qui vont être dilatés, qui vont se dilater. Ce qu'on parle de. Donc, cette défaillance circulatoire, il va avoir la première récupération.

Il est sur les reins. Les reins, ils sont époporés. C'est des gens qui vont développer une insuffisance rénale aiguë dans les 24 heures.

Si jamais on ne la traite pas par l'apport de liquide, on peut on peut passer à l'insuffisance rénale organique. Donc, surtout dû à ce problème circulatoire est d'obtenir un schéma qui illustre ce qu'on a vu dans la physiopathologie. Donc, on aura les péritonites secondaires et primitives.

Donc, on aura les hypersecrétions. On aura troisième secteur. On peut avoir avec le troisième secteur.

On va avoir un illustre paralysique qui va donner une hyperprovision rénale avec des signes circulatoires des pauvres ennemis jusqu'au choc. Sinon, on aura la déviation de substance bactérienne qui va donner un choc septique, donc qui est parfois mortel. Comment on fait le diagnostic d'une péritonite aiguë? On va prendre comme type de description la péritonite par perforation du cerf gastroduodénal chez un patient jeune.

Les signes fonctionnels sont dominés par la douleur abdominale. La douleur abdominale, c'est une douleur d'installation brutale. Elle est continue.

Elle est d'abord localisée dans ce cas précis de péritonite par perforation du cerf au niveau de l'épigastre. Il va être en quelques minutes ou quelques heures diffuse parce qu'on a le liquide qui va être abandonné au niveau de l'endomène. On peut avoir des signes réflexes comme les vomissements et les nausées, mais la douleur abdominale reste le signe le plus caractéristique.

Elle est présente chez tous les patients qui ont une péritonite aiguë, sauf chez les patients qui ont un trouble de conscience, qui n'arrivent pas à manifester leur douleur. On va poser des questions à ce patient. On va faire un interrogatoire et on va demander à un patient.

On va trouver que le patient a le plus souvent des antécédents du cerf gastrodégénal, traité ou non traité, documenté ou non documenté. Il a des antécédents de douleur épigastrique ou bien il va. Il vient de prendre un médicament, ce qu'on appelle les médicaments gastro toxiques, surtout les anti inflammatoires stéroïdiens, non stéroïdiens.

Les signes généraux au début, on peut avoir une température normale. C'est pourquoi, dans les questions d'examen, on va poser cette question. C'est une péritonite chimique.

On peut dans lorsqu'on diagnostique lorsqu'on reçoit un patient qui a une péritonite par perforation du cerf dans les premières heures, on aura une température presque normale. On peut avoir des signes circulatoires comme une tachycardie. Sinon, on peut avoir une tension artérielle qui est abaissée, sinon un état de choc.

Les signes physiques sont les plus importants. Le signe pathognomonique, c'est quoi? C'est la contracture abdominale à l'inspection. Déjà, on va voir qu'elle a tellement mal quand le ventre est immobile, rétracté.

Elle a tellement mal qu'elle n'arrive pas à bouger son ventre. Et puis, on aura une contracture abdominale qui est un signe physique objectif. C'est une résistance ou résistance de la paroi abdominale qui est douloureuse, invisible et permanente.

Donc, les quatre, les quatre adjectifs et les résistants, la paroi et la résistance, la paroi de l'abdomen, il est douloureuse, invisible et permanente. Sinon, si on n'a pas de contracture, on va avoir une défense généralisée et la défense, on a défini dans en sémiologie et en appendicite aiguë. La percussion, pourvu que ça fait pas mal, on va trouver au niveau de l'air hépatique, normalement, on a une hématite.

Mais puisqu'on a une perforation, on peut avoir de l'air qui va monter en haut. On peut avoir cette hématite qui va être qui va être absente. On va avoir une personnalité.

Sinon, on peut avoir un épanchement dans le ventre et lorsqu'on va faire la percussion, on va trouver une hématite développée. Le toucher rectal, c'est pas comme dans l'appendicite. Ici, on va avoir une douleur au niveau du sac du glas.

Donc, on a dit que ça oriente vers une péritonite. On va demander des examens cliniques pour confirmer la péritonite et parfois être orienté sur l'étiologie. On va demander, le premier

examen ici à demander, c'est une radiographie de l'endomène sans préparation.

Il est face debout et surtout centré sur le copôle. Ce qu'ils vont montrer, c'est cette image-là de croissants gazeux interhépatos diaphragmatiques. C'est difficile.

C'est difficile à mettre en évidence à gauche, mais parfois on peut le voir. Mais ici à droite, normalement ça n'existe pas. On aura la ligne opaque qui est le diaphragme.

Ici, on aura le croissant gazeux, ce qu'on appelle un pneumo-péritone. Sinon, on peut avoir une grisaille diffuse. C'est-à-dire qu'ici, les anses intestinales, leur bord n'est pas très clair.

On va être un petit peu spéculé. Sinon, on peut trouver des niveaux hydrauliques, comme une occlusion réflexe en présence d'un pneumo-péritone. Ça confirme le diagnostic.

Ça ne peut pas attendre un autre examen, sauf dans des cas particuliers. Ça permet. On n'a pas à demander un autre examen et on va pouvoir opérer le patient.

Si jamais la radiographie de l'endomène sans préparation ne montre pas de pneumo-péritone, on peut demander une échographie qui va mettre en évidence un épanchement abdominal. On va voir son écougénéité un petit peu épais en faveur du puits. C'est ça l'échographie qui va montrer un épanchement abdominal épais.

Parce qu'ici, on a la vécie, un liquide hypo-écogène. Donc, un écogène, c'est le liquide de la vécie. Ici, on aura un épanchement dans l'occulte de sable doublé.

Ça, c'est un épanchement, ici, qui est dans le contexte d'une douleur aiguë avec l'effondrement. C'est en faveur d'une période de l'abdominal. Ça, c'est la forme typique de la péritonite, pas perforation du cerveau chez un adulte jeune.

Elle est la forme la plus typique. Sinon, on peut avoir d'autres formes étiologiques. C'est dans, on l'a vu dans les appendices aigües.

La péritonale pendiculaire, c'est la douleur qui a commencé au niveau de la fossile à droite. La température est très élevée à 39-40. Et puis, l'effondrement, il est général, mais il est maximum au niveau de la fossile à droite.

La péritonite génitale, c'est la forme. C'est surtout, on va demander à la femme, si elle a des pertes. Elle va avoir des leucorrhées.

Et puis, la défense, elle est maximale. La douleur, elle a débuté au niveau de l'hypogastre. Et la défense, elle est maximale au niveau de l'hypogastre.

Et le sujet vaginal, ici, il tient tout son intérêt. On va trouver des masses latérotorines en faveur d'un piocelle. Piocelle, pense plutôt, du sel pégite masse.

Il va même objectiver les pertes vaginales. L'apéritif biliaire, c'est possible dans les patients qui

avaient des colic cystites. Donc, la douleur, ça commence au niveau de l'hépocondroïde et la défense est maximale au niveau de la, de la, de l'hépocondroïde et lorsqu'on va faire l'interrogatoire, c'est un patient qui va avoir des coliques hépatiques dans les antécédents.

La particularité de l'apéritif biliaire, c'est qu'il n'y a pas de signe clinique. La défense n'est pas très manifestée. La perforation intestinale, c'est une utilisation possible, pas très rare, de l'apéritonite.

C'est lorsqu'on a une ouverture de l'intestin, ça peut être le grêle ou le côlon. Ici, le syndrome infectieux est très sévère, l'état général est altéré, le plus souvent parce que c'est immoral. L'installation d'un état de choc, elle est rapide et l'ASP, comme l'apéritonite va montrer un plume péritoine.

Les causes coliques sont le plus souvent les cancers dans notre contexte, le diverticule, la diverticulose colique dans les pays occidentaux et chez nous aussi, les ischémies coliques. Sinon, c'est un patient qui vient de faire une endoscopie colique, une coloscopie. On peut avoir une perforation, ce qu'on appelle les perforations iatrogènes.

Pour l'intestin grêle, le plus souvent, c'est les infections du grêle, l'agressivité fluide, un diverticule de Miquel qui peut saigner ou s'inflammer. Il peut se perforer et donner l'épéritonite et sinon, parmi les chirurgies, le préfèrent dans notre contexte, c'est les traumatismes fermés ouverts, les accidents de la voie publique, les agressions par ambulance. On peut avoir une solution de conduite et une blessure de l'intestin grêle ou bien de côlon qui va donner une péritonite par perforation intestinale.

La particularité de l'apparition postopératoire, c'est qu'il est, ça survient chez un patient opéré. La douleur, c'est difficile à faire la part des choses entre une douleur postopératoire normale avec une douleur d'une péritonite postopératoire, le plus souvent chez des patients qui ont eu des sutures digestives qu'on a enlevé une partie de l'estomac, une part ou bien une partie de l'intestin grêle ou une partie de du côlon. Parfois, les patients qui ont une colostomie, on peut avoir une fuite biologique.

Il y a ça va donner une péritonite postopératoire. Le patient est déjà opéré, donc c'est un terrain qui est très fragile. Donc, la clinique, le plus souvent, il est pauvre.

C'est pourquoi on s'aide pas mal d'examens, d'examens paracliniques biologiques et radiologiques. C'est pourquoi l'intérêt de ces examens pour mettre en évidence une période postopératoire. Comment traiter une péritonite? Il faut savoir que.

Une péritonite, on ne peut la traiter que dans un dans une unité médico-chirurgicale, dans un hôpital avec présence d'un bloc qui est opérationnel 24 heures du 24. Le but du traitement, c'est de corriger les conséquences de la péritonite par une réanimation adéquate. Le principe, c'est d'évacuer le pus, de faire la toile péritonienne et surtout d'enlever la cause de traiter la cause léthologique.

Le traitement médical, c'est la voie veineuse avec les réanimations, l'apport de l'apport de solvants, de liquide, une antivitérapie adaptée à la péritonite. Le traitement, il est surtout chirurgical. On peut avoir une voie d'abord conventionnelle, la plus ancienne.

On peut faire des laparotomies, une laparotomie, c'est l'ouverture du ventre. Le plus souvent, c'est une laparotomie médiane qui va donner un jour sur l'abdomen. Sinon, parmi les meilleurs voies maintenant, c'est la celluloscopie.

On peut faire un trou, introduire une caméra et voir tout l'abdomen. Et faire le geste, évacuer le pus, faire la vache et surtout enlever les tuologies. Lorsqu'on a une perforation du cerveau gastrointestinal, on peut le suturer.

Sinon, c'est les difficultés au niveau gastrique, on peut l'enlever. L'ulcéastome, on parle de l'ulcéectomie, on peut faire une péloroplastie, mais ça, c'est le domaine du spécialiste. Regardez ça, c'est une péloroplastie, ici, chez une péritonite.

La péloroplastie, c'est comme ça. On ouvre le pylore dans un sens et on le ferme dans l'autre sens. On peut avoir comme ça.

La péritonite appendiculaire, on l'a vu dans l'appendicite. On peut avoir une appendicite, mais avec un drainage. Dans la péritonite génitale, c'est la cellulologie parce que ça permet de faire le traitement des causes, surtout la salpingite et surtout la celluloscopie.

Elle est réputée de ne pas donner beaucoup d'adhérence. Donc, il va, il va, il va préserver, entre guillemets, la fécondité de la femme. C'est pas comme la voie conventionnelle qui va donner beaucoup d'adhérence.

Il a, il a prouvé son efficacité dans les, dans toutes les péritonites, mais surtout dans les péritonites génitales. Donc, la péritonite biliaire, on fait la colostomie avec le lavage, avec le drain, le lavage de la cavité abdominale. La perforation intestinale, on va faire lorsqu'on a un intestin avec du pu.

On ne les situe pas. On fait ce qu'on appelle l'astomie, l'astomie, c'est l'abouchement de la perforation à la peau comme ici, NECA, et on va l'appareiller. Donc, le pronostic des péritonites dépend de plusieurs choses, surtout de l'état du patient, son âge physiologique, l'écomorbidité, un patient qui a un diabète déséquilibré, qui a une cardiopathie, qui est suivi pour un cancer.

C'est pas comme un patient jeune. L'étiologie de la péritonite, donc on peut avoir la péritonite appendiculaire et de bons pronostics, très bons pronostics. Par contre, la péritonite sur un cancer de cancer acrylique, c'est un petit peu plus, c'est un pronostic plus fraîcheur et surtout, surtout le délai de la prise en charge et diagnostique est thérapeutique.

Donc, seule la chirurgie précoce avec une réanimation adaptée permet d'améliorer le pronostic pour vous dire que le diagnostic d'une péritonite, il est surtout clinique, le diagnostic, l'intégrateur oriente le diagnostic étologique, le traitement, il est médico chirurgical, mais

surtout la chirurgie curative et le pronostic, il dépend, excusez la faute du thé, la rapidité de la prise en charge et je vous remercie.